

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos somatomorfos** —actualmente denominados en el **DSM-5** como **Trastornos de Síntomas Somáticos y Trastornos Relacionados**— se caracterizan por la **presencia de síntomas físicos persistentes que no pueden explicarse completamente por una enfermedad médica**, aunque el sufrimiento y la discapacidad son reales y clínicamente significativos.

Estos pacientes presentan una **preocupación excesiva por los síntomas**, una **ansiedad constante respecto a la salud** y una **búsqueda repetida de atención médica**.

Relevancia clínica

- Constituyen **hasta el 20–30% de las consultas médicas en atención primaria**.
- Implican un **alto costo sanitario**, debido a exámenes innecesarios y uso reiterado de servicios de urgencia.
- Generan **frustración tanto en el paciente como en el equipo de salud**, si no se reconocen y abordan adecuadamente.
- En el adulto mayor, los síntomas somáticos pueden enmascarar **depresión o ansiedad**, por lo que el **diagnóstico diferencial es esencial**.

Ejemplo clínico típico (EUNACOM):

Mujer de 40 años consulta reiteradamente por dolor abdominal y cefalea. Tiene múltiples exámenes normales y expresa “temor a tener cáncer”. Refiere ansiedad, insomnio y preocupación constante por su salud.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Definición general (DSM-5)

El **trastorno de síntomas somáticos** implica:

- Uno o más **síntomas físicos persistentes** que causan malestar significativo o interferencia con la vida diaria.

- **Pensamientos, sentimientos o conductas excesivas** relacionados con los síntomas (preocupación desproporcionada, ansiedad, búsqueda constante de atención).
 - Los síntomas son **persistentes (>6 meses)**, aunque pueden variar en intensidad.
-

2.2. Bases neurobiológicas

- **Hiperactividad del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS):** liberación de cortisol ante estrés crónico.
 - **Alteraciones en la interocepción** (percepción de sensaciones corporales) → amplificación de señales normales.
 - **Disfunción serotoninérgica y noradrenérgica:** explica la comorbilidad frecuente con ansiedad y depresión.
 - **Neuroimagen funcional:** hiperactivación de corteza cingulada anterior e ínsula ante estímulos somáticos inocuos.
-

2.3. Modelo biopsicosocial

El modelo actual entiende el trastorno como el resultado de la interacción entre:

1. **Factores biológicos:** vulnerabilidad genética, hipersensibilidad visceral.
2. **Factores psicológicos:** rasgos de ansiedad, alexitimia (dificultad para expresar emociones).
3. **Factores sociales:** estrés laboral, conflictos familiares, experiencias de enfermedad en el entorno.

□ En síntesis: el paciente *no finge* los síntomas. Su malestar es genuino, pero surge de una **alteración en la interpretación y amplificación de sensaciones corporales**.

2.4. Clasificación principal (DSM-5 / CIE-10)

- **Trastorno de síntomas somáticos.**

- Trastorno de ansiedad por enfermedad (antes hipocondría).
 - Trastorno de conversión (síntomas neurológicos funcionales).
 - Trastorno facticio (simulación inconsciente).
 - Simulación (fingimiento consciente con beneficio externo).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Características clínicas generales

- Síntomas somáticos **múltiples, cambiantes o inespecíficos** (dolor, fatiga, molestias gastrointestinales, mareo).
 - Ausencia de correlato anatómico o fisiológico en exámenes.
 - Alta preocupación y ansiedad por el cuerpo.
 - Historia prolongada de consultas médicas sin hallazgos relevantes.
 - Rechazo a explicaciones psicológicas (“no es algo de la cabeza, doctor”).
 - Frecuentemente se asocia a **trastornos del ánimo o trastornos de ansiedad**.
-

3.2. Subtipos clínicos más relevantes

Tipo	Características distintivas
Trastorno de síntomas somáticos	Síntomas físicos persistentes + preocupación excesiva.
Trastorno de ansiedad por enfermedad (hipocondría)	Temor de tener una enfermedad grave pese a exámenes normales.

Trastorno de conversión (funcional)	Síntomas motores o sensoriales (parálisis, ceguera, convulsiones no epilépticas) sin base neurológica.
Trastorno facticio	El paciente induce o simula síntomas por necesidad de asumir rol de enfermo.
Simulación (malingering)	Fingimiento consciente con beneficio externo (evitar trabajo, obtener compensación).

3.3. Ejemplos clínicos

- **Somatomorfo clásico:** mujer con cefaleas y fatiga crónica sin hallazgos; insiste en exámenes nuevos.
- **Hipocondríaco:** hombre de 50 años con miedo constante a tener cáncer de colon pese a colonoscopia normal.
- **Conversión:** adolescente con parálisis súbita tras conflicto emocional.
- **Facticio:** paciente que contamina su herida quirúrgica para prolongar hospitalización.

3.4. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Enfermedad médica real	Correlación anatómica, exámenes alterados, curso predecible.
Trastorno de ansiedad generalizada	Preocupación excesiva por múltiples áreas, no solo salud.

Depresión	Síntomas físicos acompañados de ánimo bajo y anhedonia.
Trastorno psicótico	Ideas delirantes somáticas fijas, sin crítica de realidad.
Simulación	Motivación externa evidente (económica, legal).

☐ **Claves en EUNACOM:**

- Hipocondría: miedo irracional a estar enfermo.
- Conversión: síntomas neurológicos sin base médica.
- Facticio: busca el “rol de enfermo” sin ganancia externa.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Enfoque diagnóstico

1. **Anamnesis completa:** explorar historia de síntomas, evolución, creencias sobre la enfermedad.
2. **Examen físico completo:** para excluir patología médica real.
3. **Historia psiquiátrica:** antecedentes de ansiedad, depresión o trauma.
4. **Evaluar funcionalidad y repercusión emocional.**

☐ El diagnóstico es **positivo**, no de exclusión: se reconoce la presencia de síntomas + pensamientos o conductas desproporcionadas, más allá de si existe una enfermedad médica concomitante.

4.2. Exámenes complementarios

- Se solicitan **solo los necesarios** para descartar causas médicas plausibles.

- Exámenes excesivos **refuerzan la conducta de búsqueda y ansiedad**.
 - En trastornos funcionales, estudios suelen ser normales (TAC, EEG, EMG, laboratorios).
-

4.3. Criterios DSM-5 para Trastorno de Síntomas Somáticos

1. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar significativo.
2. Pensamientos, sentimientos o conductas excesivas respecto a los síntomas.
3. Persistencia >6 meses, aunque los síntomas varíen.

Especificar:

- Con predominio de dolor.
 - Curso persistente (crónico).
 - Intensidad leve, moderada o grave.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El objetivo del tratamiento es **reducir la ansiedad, mejorar la funcionalidad y evitar la cronificación del cuadro**, más que eliminar los síntomas físicos por completo.

5.1. Psicoeducación

- Explicar que los síntomas son **reales y no imaginarios**, pero **funcionales**.
- Reforzar la idea de que el cuerpo y la mente están conectados.
- Evitar frases invalidantes (“todo está en su cabeza”).
- Enseñar el concepto de **estrés somático** y técnicas de autocontrol.

□ Ejemplo:

“Su cuerpo reacciona al estrés con síntomas físicos. Podemos trabajar juntos para que eso mejore.”

5.2. Psicoterapia (tratamiento de primera línea)

- **Terapia cognitivo-conductual (TCC):**
 - Reduce preocupación por la salud y conductas de búsqueda médica.
 - Enseña reinterpretación de sensaciones corporales.
 - Evidencia sólida de eficacia (MINSAL, NICE).
 - **Terapia psicodinámica breve:** útil en casos asociados a conflictos emocionales inconscientes.
 - **Terapia grupal o familiar:** mejora apoyo social y comprensión del problema.
-

5.3. Tratamiento farmacológico

Indicaciones:

- Comorbilidad con **depresión o ansiedad significativa**.
- Síntomas persistentes pese a psicoterapia.

Antidepresivos ISRS (primera elección)

Fármaco	Dosis inicial	Dosis usual	Comentarios
Sertralina	25 mg/día	50–100 mg/día	Bien tolerada, segura en mayores.
Escitalopram	5 mg/día	10–20 mg/día	Menor interacción medicamentosa.
Fluoxetina	10 mg/día	20 mg/día	Activadora; evitar si hay insomnio.

Otros fármacos:

- **Duloxetina o venlafaxina:** si predominan síntomas dolorosos (fibromialgia, fatiga).
- **Benzodiacepinas:** evitar uso prolongado; sólo en ansiedad aguda, máximo 2 semanas.

□ La farmacoterapia **no elimina los síntomas físicos**, pero **modula la ansiedad y percepción corporal**.

5.4. Manejo médico coordinado

- Designar un **médico tratante único** para seguimiento.
 - Establecer **controles periódicos programados**, evitando consultas de urgencia repetitivas.
 - Escuchar activamente y validar el malestar en cada visita.
 - Evitar derivaciones innecesarias.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Cronificación del cuadro con discapacidad funcional.
- Abuso de medicamentos y dependencia médica.
- Aislamiento social y laboral.
- Comorbilidad con depresión mayor o trastornos de ansiedad.
- Riesgo de procedimientos invasivos innecesarios.

6.2. Pronóstico

- El curso suele ser **crónico y fluctuante**, con mejoría parcial.
- Factores de buen pronóstico:

- Relación terapéutica empática y estable.
 - Inclusión de psicoterapia temprana.
 - Reconocimiento del vínculo entre emociones y cuerpo.
 - Factores de mal pronóstico:
 - Personalidad dependiente o histriónica.
 - Conflictos familiares persistentes.
 - Resistencia al abordaje psicológico.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Los síntomas son **reales**, aunque no tengan base orgánica demostrable.
 2. En **hipocondría**, el foco no está en el síntoma sino en el **miedo a estar enfermo**.
 3. El **trastorno de conversión** cursa con síntomas neurológicos “inexplicables”, a menudo tras estrés emocional.
 4. La **TCC** es el tratamiento más eficaz para reducir la preocupación somática.
 5. Los **ISRS** son útiles en presencia de ansiedad o depresión comórbida.
 6. El **seguimiento regular y médico único** previene la iatrogenia.
 7. La comunicación empática es más terapéutica que los exámenes complementarios.
-



Errores comunes

- Etiquetar al paciente como “simulador” o “manipulador”.

- Solicitar exámenes repetidos sin justificación.
 - Suspender el seguimiento al no hallar causa orgánica.
 - Usar benzodiazepinas crónicamente.
 - No derivar a psicoterapia por prejuicio (“no lo aceptará”).
 - Ignorar comorbilidad depresiva o ansiosa.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **trastornos somatomorfos** implican síntomas físicos genuinos **sin base médica suficiente**, pero con malestar real.
2. El **trastorno de síntomas somáticos** se diagnostica por la **reacción emocional y conductual excesiva** frente al síntoma.
3. La **Terapia Cognitivo-Conductual** es el tratamiento más eficaz y debe iniciarse precozmente.
4. Los **ISRS** son útiles cuando existe comorbilidad depresiva o ansiosa.
5. Evitar **exámenes innecesarios** y mantener **un médico tratante estable**.
6. La **comunicación empática** es clave para reducir ansiedad y mejorar adherencia.
7. Con abordaje integral, la mayoría de los pacientes mejora su funcionalidad y reduce la búsqueda médica repetida.